模拟教学医院

住院病案复印件式汇编

急性广泛前壁ST段抬高型心肌梗死

急诊冠状动脉介入治疗及药物洗脱支架置入成功

项目	病案信息
患者	张建国（虚构），男，58岁
病案号	SIM-AMI-20260901
住院期间	2026年9月1日09:20 至 9月7日10:00
核心事件	前降支近段急性血栓性闭塞；急诊置入药物洗脱支架1枚
出院转归	好转；LVEF由45%改善至50%
文件版本	专家审核版 v1.0 / 编制日期：2026-09-10

使用说明

本件按医院病案复印资料的阅读顺序和检验单版式制作，全部为教学合成数据。仅供临床专家审核病例逻辑、诊疗合理性及教学适用性。未使用真实机构标识、公章、签名或真实患者信息。

检验报告含标本类型、采样/接收/报告时间、参考区间及异常箭头。↑表示高于上限，↓表示低于下限；疾病治疗目标与实验室参考区间分别说明。

心电图为按病例参数绘制的校准示意波形，并非设备采集记录。超声、胸片及冠脉造影提供文字报告和对应结构/运动示意图；所有图片均明确标注合成属性。

签名栏仅为模拟角色标识。此汇编不是具备法定效力的完整归档病案，不包含真实知情同意签署、费用凭据或护理原始执行凭证。

编制：临床思维训练系统 临床专家审核：待完成（均为角色标识，未作真实签署）

模拟教学医院

登记信息与资料同步说明

姓名：张建国（虚构） 性别：男 年龄：58岁 病案号：SIM-AMI-20260901

科室：心血管内科 / CCU 入院：2026-09-01 09:20 出院：2026-09-07 10:00

同步日期：2026-09-14。来源任务：1.2胸痛病例-整体规划。医学主稿仍为v1.0，待专家审核；本次同步不是病例v1.2，也不代表临床审核通过。

登记项目	当前教学设定
姓名 / 性别 / 年龄	张建国（虚构） / 男 / 58岁
民族 / 籍贯	汉族 / 安徽省合肥市
婚姻 / 职业	已婚 / 企业行政人员
现住址	四川省成都市武侯区康宁路18号春和苑2栋301室（教学虚构）
病史陈述者	患者本人
登记状态	已办理入院，登记资料齐备

原医学病程、手术、药物实际使用和血液数值未改。最新38项分阶段报告、68项HIS药品目录及其参考资料在病例生成区完整资料页提供。药库版本2026-09-11.2，与医学主稿版本不同；收录药物不代表患者使用。全部药库仍待本地药学核验。

生活背景只保留任务中明确固定的虚构资料；不将模型自由发挥、学员对话、检查操作或医嘱会话写入标准病例。原始PDF另行留档。

模拟教学医院

入院记录（一）

姓名：张建国（虚构） 性别：男 年龄：58岁 病案号：SIM-AMI-20260901

科室：心血管内科 / CCU 入院：2026-09-01 09:20 出院：2026-09-07 10:00

一般资料

姓名张建国，男，58岁，已婚，企业行政人员。籍贯安徽省合肥市，现居成都。急诊入院，病史由本人提供，陈述可靠。记录时间：2026-09-01 09:35，评估与救治同步。

主诉

持续胸骨后压榨样疼痛伴大汗1小时20分钟。

现病史

2026-09-01 08:00搬运物品时突发胸骨后压榨样疼痛，约手掌大小范围，向左肩及左上臂内侧放射，疼痛8/10分，伴大汗、恶心及胸闷。停止活动并休息约20分钟无明显缓解，疼痛持续。09:20由家属陪同到达本院急诊，此前未接受院前医疗处理。09:25心电图提示V_1～V_6导联ST段抬高，立即启动导管室。

相关阳性与阴性病史

近2周上楼、快步行走时曾有胸骨后闷痛3次，每次3～5分钟，休息缓解，未就诊。此次无撕裂样胸背痛，无呼吸或体位相关疼痛，无发热、咳嗽、咯血、晕厥及肢体活动障碍，无单侧下肢肿痛。近3个月无手术、长期卧床及长途制动史。发病前饮食睡眠尚可，二便正常，近期体重无明显变化。

既往史

高血压8年，最高约170/100 mmHg，间断服氨氯地平5 mg每日1次，依从性差，平时145～160/90～100 mmHg。2年前发现血脂升高，未规律治疗。否认既往心肌梗死、PCI、心力衰竭、糖尿病、脑卒中及慢性肾病史。否认活动性溃疡、消化道出血、颅内出血、凝血障碍及近期重大创伤手术史。无长期抗凝药使用。否认哮喘、严重慢性肺病、肝炎、结核及输血史。

过敏与近期用药

否认已知药物及造影剂过敏。近期未使用西地那非等PDE-5抑制剂。

记录医师：模拟医师A 审核医师：模拟医师B（均为角色标识，未作真实签署）

模拟教学医院

入院记录（二）

姓名：张建国（虚构） 性别：男 年龄：58岁 病案号：SIM-AMI-20260901

科室：心血管内科 / CCU 入院：2026-09-01 09:20 出院：2026-09-07 10:00

个人史、婚育史及家族史

吸烟30年，约20支/日，累计约30包年；偶尔饮酒，无大量饮酒史。运动少，偏咸高脂饮食，无特殊职业接触史。已婚，育有1子，配偶及子女体健。父亲54岁发生心肌梗死，母亲有高血压；否认已知遗传性心肌病及家族性猝死史。

生命体征

T 36.5℃，P 92次/分，R 22次/分；右臂BP 148/92 mmHg、左臂146/90 mmHg；空气下SpO_2 96%。身高172 cm，体重78 kg，BMI 26.4 kg/m^2。

体格检查

神志清楚，急性痛苦面容，皮肤湿冷，口唇无发绀，巩膜无黄染。颈静脉无怒张，气管居中。双肺呼吸音清，无干湿啰音。心率92次/分，律齐，心音稍低，无病理性杂音、第三心音及心包摩擦音。腹平软，无压痛及反跳痛，肝脾肋下未及。双下肢无水肿或不对称肿胀，双侧桡动脉及足背动脉搏动对称。神经系统无局灶性异常。

急诊初步检查

09:25心电图：窦性心律，V_1～V_6 ST段抬高，Ⅲ、aVF对应性压低。09:28采集血液标本，肌钙蛋白尚未回报时已启动紧急再灌注，不等待检验结果。

入院初步诊断

1. 冠状动脉粥样硬化性心脏病：急性广泛前壁ST段抬高型心肌梗死，KillipⅠ级。
2. 原发性高血压，2级，很高危。
3. 血脂异常。

记录医师：模拟医师A 审核医师：模拟医师B（均为角色标识，未作真实签署）

模拟教学医院

首次病程记录

姓名：张建国（虚构） 性别：男 年龄：58岁 病案号：SIM-AMI-20260901

科室：心血管内科 / CCU 入院：2026-09-01 09:20 出院：2026-09-07 10:00

记录时间：2026-09-01 09:40

病例特点

58岁男性，高血压、血脂异常、长期吸烟及早发冠心病家族史。近2周劳力性胸痛，此次持续胸痛超过1小时，伴大汗及恶心；相邻胸前导联明显ST段抬高，伴下壁对应性压低。无肺啰音、第三心音或低血压。

诊断及依据

急性广泛前壁STEMI。典型缺血性胸痛和定位性ST段抬高足以启动紧急再灌注路径。后续须结合肌钙蛋白动态及造影确认梗死机制。目前Killip Ⅰ级。

鉴别诊断

①主动脉夹层：无撕裂痛、显著臂间血压差、脉搏缺失及神经症状，可能性低；上述阴性表现不能单独完全排除，如有新线索及时进一步评估。②肺栓塞：无主要静脉血栓风险、低氧或右心负荷表现，心电图更符合前壁冠脉闭塞。③急性心包炎：无体位相关疼痛或摩擦音，ST变化有区域性及对应性。④心肌炎、应激性心肌病：需结合冠脉及心功能检查，不能因此延迟目前再灌注。⑤消化道疾病不能解释定位性心电图改变。

诊疗计划

立即急诊冠脉造影并视情况直接PCI；给予阿司匹林及替格瑞洛负荷、介入期肝素抗凝和强化降脂。持续心电监护、建立静脉通道、备除颤设备。监测疼痛、血压、血氧、出血及心力衰竭征象；完善心肌标志物、血常规、凝血、生化及超声，不等待结果延误开通血管。

风险评估

存在前壁大面积心肌损伤风险，需警惕恶性心律失常、心源性休克、机械并发症及死亡。无明确活动性出血、长期抗凝需要或其他明显高出血风险特征；抗栓方案须在住院及随访中动态复评。

记录医师：模拟医师A 审核医师：模拟医师B（均为角色标识，未作真实签署）

模拟教学医院

急诊抢救记录

姓名：张建国（虚构） 性别：男 年龄：58岁 病案号：SIM-AMI-20260901

科室：心血管内科 / CCU 入院：2026-09-01 09:20 出院：2026-09-07 10:00

抢救时段：2026-09-01 09:20至11:05。抢救诊断：急性广泛前壁STEMI。

时间	病情及处置
09:20	胸痛8/10分、大汗；心电监护，建立静脉通道。
09:25 / 09:27	完成首份心电图，识别STEMI；启动导管室。
09:28	采集血常规、肌钙蛋白、凝血、肝肾功能、电解质及血脂标本。
09:30	阿司匹林普通片300 mg嚼服；替格瑞洛180 mg口服。
09:32	确认血压及禁忌证后硝酸甘油0.5 mg舌下含服1次；疼痛降至6/10分，BP 136/84 mmHg。
09:35 / 09:40	阿托伐他汀40 mg口服；说明PCI方案及风险，模拟同意流程完成。
09:50 / 09:52	hs-cTnI 186 ng/L回报；进入导管室。
10:04 / 10:12	造影见前降支近段完全闭塞；导丝通过病变。
10:16 / 10:24	首次球囊扩张，恢复前向血流；置入药物洗脱支架1枚。
10:38 / 10:45	末次造影TIMI 3级，胸痛基本消失；手术结束。
11:05	转CCU，循环稳定。

到院至心电图5分钟，至导丝通过52分钟，至首次球囊扩张56分钟；发病至首次球囊扩张2小时16分钟。

SpO_2全程95%～97%，未常规吸氧。无心脏骤停、持续性室速/室颤及休克，未行胸外按压、除颤或升压药治疗。抢救成功指紧急再灌注成功、症状缓解、循环稳定。

抢救医师：模拟医师A 协同医师：模拟医师B（均为角色标识，未作真实签署）

模拟教学医院

术前记录及知情沟通摘要

姓名：张建国（虚构） 性别：男 年龄：58岁 病案号：SIM-AMI-20260901

科室：心血管内科 / CCU 入院：2026-09-01 09:20 出院：2026-09-07 10:00

记录时间：2026-09-01 09:45；拟手术时间：当日急诊。

术前诊断

急性广泛前壁ST段抬高型心肌梗死。

手术指征

症状不足12小时，持续缺血性胸痛，明确ST段抬高，具备立即直接PCI条件。

拟行术式

选择性冠状动脉造影，必要时冠状动脉球囊扩张及支架置入术，结合需要进行血管内影像检查。

术前评估

患者神志清楚，有自主表达能力，BP稳定，未见肺淤血及休克。已给予双联抗血小板负荷；无已知造影剂过敏、活动性出血及近期重大手术史。检验检查与急诊准备同步，未为等待肾功能等结果延误再灌注。

沟通内容

解释前壁急性心梗的生命危险、紧急开通血管的获益及药物治疗、溶栓等替代策略。本院可及时PCI，选择直接PCI。说明出血、血管损伤、过敏、肾损伤、冠脉夹层/穿孔、无复流、支架血栓、紧急外科手术及死亡等风险。患者表示理解并同意；家属参与沟通。

麻醉及准备

局部麻醉，右桡动脉入路优先；复核身份、术式、过敏史、抗血小板负荷及抢救设备。

文书属性

本页为模拟沟通摘要，不替代真实患者签署的介入手术知情同意书；不生成或模仿真实签字。

记录医师：模拟医师A 审核医师：模拟医师B（均为角色标识，未作真实签署）

模拟教学医院

冠状动脉介入手术记录（一）

姓名：张建国（虚构） 性别：男 年龄：58岁 病案号：SIM-AMI-20260901

科室：心血管内科 / CCU 入院：2026-09-01 09:20 出院：2026-09-07 10:00

日期：2026-09-01 开始：09:55 结束：10:45 麻醉：局部麻醉

术式：冠脉造影＋前降支球囊扩张＋药物洗脱支架置入＋血管内超声（IVUS）。

入路、抗凝与造影

常规消毒铺巾，1%利多卡因局部浸润麻醉，经右桡动脉置入6 F鞘。普通肝素7,000 U静脉注射，约90 U/kg；术中ACT 286秒。未用糖蛋白Ⅱb/Ⅲa拮抗剂。

血管	造影结果
冠脉优势型	右优势型
左主干（LM）	无明显狭窄
左前降支（LAD）	第一对角支开口前近段完全闭塞，残端不规则、伴血栓征象；TIMI 0级。
左回旋支（LCX）	中段约30%狭窄；TIMI 3级。
右冠状动脉（RCA）	中段约40%狭窄；TIMI 3级。

病变处理

判断前降支为梗死相关血管。经6 F EBU 3.5指引导管送入工作导丝，10:12通过闭塞至前降支远端。10:16以2.0×15 mm球囊预扩张，恢复TIMI 2级血流，显示残余约95%狭窄、病变长约24 mm。

血流恢复后行IVUS：病变段斑块负荷明显，伴腔内血栓征象；远端参考直径约3.0 mm，近端约3.5 mm。造影及IVUS不等同病理学，未将斑块破裂写为已经证实。

术者：模拟医师A 助手：模拟医师B（均为角色标识，未作真实签署）

模拟教学医院

冠状动脉介入手术记录（二）

姓名：张建国（虚构） 性别：男 年龄：58岁 病案号：SIM-AMI-20260901

科室：心血管内科 / CCU 入院：2026-09-01 09:20 出院：2026-09-07 10:00

支架置入及结果

10:24置入3.0×28 mm药物洗脱支架1枚，12 atm释放。以3.5×12 mm非顺应性球囊对近中段后扩张，最高16 atm，避免超出支架边缘。

复查IVUS：支架膨胀及贴壁满意，最小支架面积约7.1 mm^2，无明显边缘夹层。10:38末次造影：残余狭窄＜10%，TIMI 3级，对角支通畅，无穿孔、夹层及明显远端栓塞。非罪犯血管无重度狭窄，本次无需介入。未常规血栓抽吸。

项目	结果
支架	药物洗脱支架1枚，3.0×28 mm；不虚构厂商、批号或UDI。
造影剂	碘克沙醇110 mL
术中ACT	286秒（介入抗凝监测值，不采用未抗凝参考区间判异常）
血压	118～142/72～88 mmHg
估计失血	＜20 mL
症状	胸痛由6/10分降至0～1/10分
并发症	未发生持续性恶性心律失常、穿孔、无复流等
止血	术毕拔鞘，桡动脉压迫器止血，手部末梢循环良好

术后诊断与处理

急性广泛前壁STEMI；前降支近段急性血栓性闭塞；直接PCI成功。11:05转CCU，继续双联抗血小板及降脂治疗。无其他抗凝指征，术后不常规继续肝素。监测穿刺点、心律、心电图、血红蛋白、尿量及肾功能。

术者：模拟医师A 助手：模拟医师B（均为角色标识，未作真实签署）

模拟教学医院

主要医嘱汇总

姓名：张建国（虚构） 性别：男 年龄：58岁 病案号：SIM-AMI-20260901

科室：心血管内科 / CCU 入院：2026-09-01 09:20 出院：2026-09-07 10:00

药物/措施	剂量及途径	起止与说明
阿司匹林	300 mg嚼服负荷；100 mg口服每日1次	9月1日负荷；9月2日起维持
替格瑞洛	180 mg负荷；90 mg口服每日2次	9月1日09:30负荷，当日21:30起维持，约每12小时
普通肝素	7,000 U静脉注射	仅介入期，监测ACT；术后停用
阿托伐他汀	40 mg口服，每晚1次	9月1日09:35首剂，当日不重复；9月2日起每晚
依折麦布	10 mg口服，每日1次	9月2日起
美托洛尔缓释片	23.75 mg每日1次，后47.5 mg每日1次	9月2日起低剂量；9月4日增量
培哚普利叔丁胺片	2 mg每日1次，后4 mg每日1次	9月2日起；9月4日增量
硝酸甘油	0.5 mg舌下含服	9月1日09:32单次；出院备药
监护及活动	前48小时持续心电监护；稳定后分阶段活动	9月3日转普通病房，住院Ⅰ期康复

本表为主要医嘱整理，不是实际护理给药执行单。培哚普利明确为叔丁胺盐规格，避免与其他盐型混淆。

无临床肺淤血，未用利尿剂；LVEF＞40%、无糖尿病或临床心衰，未常规加用醛固酮受体拮抗剂。无活动性消化性溃疡、出血史及合用抗凝/NSAIDs等明显胃肠道出血危险因素，暂未常规加PPI，后续复评。

记录医师：模拟医师A 审核医师：模拟医师B（均为角色标识，未作真实签署）

模拟教学医院

病程记录（1）

姓名：张建国（虚构） 性别：男 年龄：58岁 病案号：SIM-AMI-20260901

科室：心血管内科 / CCU 入院：2026-09-01 09:20 出院：2026-09-07 10:00

2026-09-01 11:30 术后首次病程

胸痛、大汗及恶心消失。BP 126/78 mmHg，HR 78次/分，SpO_2 97%，双肺清，心律齐。右桡动脉穿刺点无出血，手指温暖、感觉正常。前降支支架后TIMI 3级，11:20心电图ST明显回落。继续双联抗血小板、他汀及监护，动态复查标志物，警惕再缺血、心衰、心律失常及出血，完成床旁超声。

记录医师：模拟医师A 审核医师：模拟医师B（均为角色标识，未作真实签署）

2026-09-01 18:00 术后观察

无胸痛或气短，BP 122/76 mmHg，HR 74次/分，尿量正常。穿刺点无渗血，按流程减压，远端灌注良好。超声LVEF 45%，前壁、前间隔及心尖运动减弱，无机械并发症。偶见单发室早，无成对室早或持续性室速，不用预防性抗心律失常药。

记录医师：模拟医师A 审核医师：模拟医师B（均为角色标识，未作真实签署）

模拟教学医院

病程记录（2）

姓名：张建国（虚构） 性别：男 年龄：58岁 病案号：SIM-AMI-20260901

科室：心血管内科 / CCU 入院：2026-09-01 09:20 出院：2026-09-07 10:00

2026-09-02 09:00 上级医师查房

夜间无胸痛、气促。BP 124/78 mmHg，HR 72次/分，双肺无啰音。hs-cTnI 32,400 ng/L，为采样最高值；心电图Q波及T倒置符合梗死演变，无新发症状及再次ST抬高，暂不考虑再梗死。结合冠脉确定1型STEMI。虽LVEF轻度降低，无临床心衰，KillipⅠ级。加美托洛尔缓释片23.75 mg每日1次、培哚普利叔丁胺片2 mg每日1次；监测心率、血压、肌酐及钾。LDL-C 4.05 mmol/L，加依折麦布10 mg每日1次。

记录医师：模拟医师A 审核医师：模拟医师B（均为角色标识，未作真实签署）

2026-09-03 09:00 日常病程及CCU转出

无胸痛、心悸及气短，可坐起并短距离步行。BP 120/74 mmHg，HR 68次/分，双肺清。穿刺点少量瘀斑，无血肿。标志物下降，肌酐84 μmol/L，血红蛋白143 g/L，无AKI及临床出血。48小时监护无持续恶性心律失常。转普通病房，交接双联抗血小板、监测出血及康复计划。

记录医师：模拟医师A 审核医师：模拟医师B（均为角色标识，未作真实签署）

模拟教学医院

病程记录（3）

姓名：张建国（虚构） 性别：男 年龄：58岁 病案号：SIM-AMI-20260901

科室：心血管内科 / CCU 入院：2026-09-01 09:20 出院：2026-09-07 10:00

2026-09-04 09:00 上级医师查房

无胸痛、气促，病房步行耐受。BP 128/78 mmHg，HR 74次/分，站立无明显头晕。CK-MB恢复参考范围。美托洛尔增至47.5 mg每日1次，培哚普利叔丁胺片增至4 mg每日1次，监测低血压、心动过缓、高钾及肾功能改变。无喘息、房室阻滞或其他药物不耐受。

记录医师：模拟医师A 审核医师：模拟医师B（均为角色标识，未作真实签署）

2026-09-05 09:00 日常病程

无胸痛、心悸及黑便。BP 118/72 mmHg，HR 66次/分。分次步行，每次5～10分钟无不适。已与患者及家属核对药名、剂量和时间，强调抗血小板不可自行停药，患者同意戒烟。无感染或静脉血栓临床表现。继续康复，拟出院前复查心电图、超声及血液。

记录医师：模拟医师A 审核医师：模拟医师B（均为角色标识，未作真实签署）

模拟教学医院

病程记录（4）

姓名：张建国（虚构） 性别：男 年龄：58岁 病案号：SIM-AMI-20260901

科室：心血管内科 / CCU 入院：2026-09-01 09:20 出院：2026-09-07 10:00

2026-09-06 09:00 出院前评估

无胸痛、气促、晕厥。BP 116/72 mmHg，HR 64次/分。Hb 145 g/L、PLT 229×10^9/L、Cr 80 μmol/L、K 4.3 mmol/L，肝功能恢复。hs-cTnI 780 ng/L，仍高于上限但持续下降，无再缺血证据。超声LVEF 50%，未见明确左室血栓。具备出院条件，已安排康复及随访。

记录医师：模拟医师A 审核医师：模拟医师B（均为角色标识，未作真实签署）

2026-09-07 09:00 出院当日病程

无胸痛、心悸或气促。BP 118/74 mmHg，HR 66次/分，空气下SpO_2 97%，双肺清、心律齐、无下肢水肿。穿刺点愈合良好，生活可自理。核对出院药物及复诊计划，患者能复述胸痛复发及出血警示症状处理方式。今日10:00出院。

记录医师：模拟医师A 审核医师：模拟医师B（均为角色标识，未作真实签署）

模拟教学医院

出院记录（一）

姓名：张建国（虚构） 性别：男 年龄：58岁 病案号：SIM-AMI-20260901

科室：心血管内科 / CCU 入院：2026-09-01 09:20 出院：2026-09-07 10:00

入院情况

因持续胸骨后压榨样疼痛伴大汗1小时20分钟入院。高血压、血脂异常及长期吸烟史。心电图V_1～V_6 ST段抬高，初始hs-cTnI 186 ng/L。无肺淤血及休克。

住院诊疗经过

启动STEMI路径，给予双联抗血小板负荷及降脂。急诊造影见前降支近段TIMI 0级闭塞，置入3.0×28 mm药物洗脱支架1枚，术后TIMI 3级。胸痛消失、ST明显回落。心肌标志物先升后降。未发生持续性恶性心律失常、临床心衰、机械并发症、重大出血及AKI。继续双联抗血小板、强化联合降脂、β受体阻滞剂及ACEI，完成早期康复和二级预防教育。LVEF由45%改善至50%。

出院诊断

1. 冠状动脉粥样硬化性心脏病：急性广泛前壁STEMI，1型；前降支近段急性血栓性闭塞；急诊PCI及药物洗脱支架置入术后；入院KillipⅠ级。
2. 原发性高血压，2级，很高危。
3. 血脂异常。

出院情况

神志清楚，无胸痛、气促、心悸。BP 118/74 mmHg、HR 66次/分。双肺清，下肢无水肿，桡动脉穿刺点恢复良好，可耐受日常轻体力活动。转归：好转。

出院依据

血流重建成功，无进行性缺血及并发症，药物治疗耐受，康复和随访已落实。肌钙蛋白尚未正常、Q波及局部运动异常持续，不妨碍在临床稳定时出院。支架置入不代表心肌完全恢复或冠心病治愈。

记录医师：模拟医师A 审核医师：模拟医师B（均为角色标识，未作真实签署）

模拟教学医院

出院记录（二）：带药及随访

姓名：张建国（虚构） 性别：男 年龄：58岁 病案号：SIM-AMI-20260901

科室：心血管内科 / CCU 入院：2026-09-01 09:20 出院：2026-09-07 10:00

药物	出院用法	复评说明
阿司匹林肠溶片	100 mg，每日1次，整片吞服	当前计划长期；随抗栓策略调整
替格瑞洛	90 mg，每日2次，约每12小时	联合阿司匹林默认至少12个月；2027年9月前后复评，期间动态评估出血
阿托伐他汀	40 mg，每晚1次	长期，按血脂及耐受调整
依折麦布	10 mg，每日1次	联合降脂，复查后调整
美托洛尔缓释片	47.5 mg，每日1次	按心率、血压、LVEF及症状复评
培哚普利叔丁胺片	4 mg，每日1次	按血压、钾、肾功能调整
硝酸甘油	0.5 mg舌下含服，备用	按指导使用，不替代呼叫120

以上常规药均为口服，硝酸甘油为舌下含服。美托洛尔不预设所有心梗患者终身固定剂量。不得自行停用抗血小板；手术、拔牙及出血需先与心内科协调。避免自行使用布洛芬、双氯芬酸等NSAIDs。

复诊计划

7～14天心内科复诊：症状、心率血压、依从性及出血评估；复查肌酐、钾，必要时血常规。4～6周复查血脂，按情况复查肝功能；LDL-C目标＜1.4 mmol/L且较基线下降≥50%。未达标则评估依从性并加强治疗。6～12周复查超声心动图。

转介门诊心脏康复。戒烟、避免二手烟，限盐及饱和脂肪，逐步控制体重。从舒适速度步行起，避免突然剧烈运动、搬重物及屏气。记录血压心率，血压通常以＜130/80 mmHg且可耐受为目标。

复发类似胸痛尤其持续＞5分钟或伴大汗、气短、晕厥：立即呼叫120，不自行驾车。按指导在无低血压或相关禁忌时用备用硝酸甘油，不等反复用药再呼救。呕血、黑便、持续出血或突发剧烈头痛、偏瘫立即急诊并告知抗血小板用药。

记录医师：模拟医师A 审核医师：模拟医师B（均为角色标识，未作真实签署）

模拟教学医院

血液检验报告单

姓名：张建国（虚构） 性别：男 年龄：58岁 病案号：SIM-AMI-20260901

科室：心血管内科 / CCU 入院：2026-09-01 09:20 出院：2026-09-07 10:00

报告编号：SIM-CBC-0901 标本：EDTA抗凝全血 标本状态：合格（模拟）

采样：09-01 09:28 接收：09:32 报告：09:45

检验项目	结果	提示	单位	参考区间
白细胞计数 WBC	12.6	↑	$\times10^9$/L	3.5 – 9.5
中性粒细胞比例	82	↑	%	40 – 75
淋巴细胞比例	11	↓	%	20 – 50
单核细胞比例	6		%	3 – 10
嗜酸性粒细胞比例	0.5		%	0.4 – 8
嗜碱性粒细胞比例	0.5		%	0 – 1
中性粒细胞计数	10.33	↑	$\times10^9$/L	1.8 – 6.3
淋巴细胞计数	1.39		$\times10^9$/L	1.1 – 3.2
单核细胞计数	0.76	↑	$\times10^9$/L	0.1 – 0.6
嗜酸性粒细胞计数	0.06		$\times10^9$/L	0.02 – 0.52
嗜碱性粒细胞计数	0.06		$\times10^9$/L	0 – 0.06
红细胞计数 RBC	4.9		$\times10^{12}$/L	4.3 – 5.8
血红蛋白 Hb	148		g/L	130 – 175
红细胞压积 HCT	44.1		%	40 – 50
平均红细胞体积 MCV	90.0		fL	82 – 100
平均红细胞血红蛋白 MCH	30.2		pg	27 – 34
平均Hb浓度 MCHC	336		g/L	316 – 354
红细胞分布宽度 RDW-CV	12.8		%	11.5 – 14.5
血小板计数 PLT	236		$\times10^9$/L	125 – 350
平均血小板体积 MPV	10.2		fL	7 – 13

结果提示：↑ 高于参考上限；↓ 低于参考下限；空白表示未超出所列区间。

新增分类计数及红细胞指数为本版补充的合成数据，与既有WBC/Hb/PLT保持一致。

参考区间为本模拟实验室设定；仅用于该教学病例，非特定品牌试剂说明书。

检验者：模拟检验师A 审核者：模拟检验师B（均为角色标识，未作真实签署）

模拟教学医院

血液检验报告单

姓名：张建国（虚构） 性别：男 年龄：58岁 病案号：SIM-AMI-20260901

科室：心血管内科 / CCU 入院：2026-09-01 09:20 出院：2026-09-07 10:00

报告编号：SIM-CBC-0903 标本：EDTA抗凝全血 标本状态：合格（模拟）

采样：09-03 06:00 接收：06:12 报告：06:40

检验项目	结果	提示	单位	参考区间
白细胞计数 WBC	9.4		$\times10^9$/L	3.5 – 9.5
中性粒细胞比例	71		%	40 – 75
淋巴细胞比例	20		%	20 – 50
单核细胞比例	7		%	3 – 10
嗜酸性粒细胞比例	1.5		%	0.4 – 8
嗜碱性粒细胞比例	0.5		%	0 – 1
中性粒细胞计数	6.67	↑	$\times10^9$/L	1.8 – 6.3
淋巴细胞计数	1.88		$\times10^9$/L	1.1 – 3.2
单核细胞计数	0.66	↑	$\times10^9$/L	0.1 – 0.6
嗜酸性粒细胞计数	0.14		$\times10^9$/L	0.02 – 0.52
嗜碱性粒细胞计数	0.05		$\times10^9$/L	0 – 0.06
红细胞计数 RBC	4.75		$\times10^{12}$/L	4.3 – 5.8
血红蛋白 Hb	143		g/L	130 – 175
红细胞压积 HCT	42.8		%	40 – 50
平均红细胞体积 MCV	90.1		fL	82 – 100
平均红细胞血红蛋白 MCH	30.1		pg	27 – 34
平均Hb浓度 MCHC	334		g/L	316 – 354
红细胞分布宽度 RDW-CV	12.9		%	11.5 – 14.5
血小板计数 PLT	221		$\times10^9$/L	125 – 350
平均血小板体积 MPV	10.1		fL	7 – 13

结果提示：↑ 高于参考上限；↓ 低于参考下限；空白表示未超出所列区间。

新增分类计数及红细胞指数为本版补充的合成数据，与既有WBC/Hb/PLT保持一致。

参考区间为本模拟实验室设定；仅用于该教学病例，非特定品牌试剂说明书。

检验者：模拟检验师A 审核者：模拟检验师B（均为角色标识，未作真实签署）

模拟教学医院

血液检验报告单

姓名：张建国（虚构） 性别：男 年龄：58岁 病案号：SIM-AMI-20260901

科室：心血管内科 / CCU 入院：2026-09-01 09:20 出院：2026-09-07 10:00

报告编号：SIM-CBC-0906 标本：EDTA抗凝全血 标本状态：合格（模拟）

采样：09-06 06:00 接收：06:12 报告：06:40

检验项目	结果	提示	单位	参考区间
白细胞计数 WBC	7.2		$\times10^9$/L	3.5 – 9.5
中性粒细胞比例	63		%	40 – 75
淋巴细胞比例	27		%	20 – 50
单核细胞比例	7		%	3 – 10
嗜酸性粒细胞比例	2.5		%	0.4 – 8
嗜碱性粒细胞比例	0.5		%	0 – 1
中性粒细胞计数	4.54		$\times10^9$/L	1.8 – 6.3
淋巴细胞计数	1.94		$\times10^9$/L	1.1 – 3.2
单核细胞计数	0.5		$\times10^9$/L	0.1 – 0.6
嗜酸性粒细胞计数	0.18		$\times10^9$/L	0.02 – 0.52
嗜碱性粒细胞计数	0.04		$\times10^9$/L	0 – 0.06
红细胞计数 RBC	4.81		$\times10^{12}$/L	4.3 – 5.8
血红蛋白 Hb	145		g/L	130 – 175
红细胞压积 HCT	43.5		%	40 – 50
平均红细胞体积 MCV	90.4		fL	82 – 100
平均红细胞血红蛋白 MCH	30.1		pg	27 – 34
平均Hb浓度 MCHC	333		g/L	316 – 354
红细胞分布宽度 RDW-CV	12.8		%	11.5 – 14.5
血小板计数 PLT	229		$\times10^9$/L	125 – 350
平均血小板体积 MPV	10.2		fL	7 – 13

结果提示：↑ 高于参考上限；↓ 低于参考下限；空白表示未超出所列区间。

新增分类计数及红细胞指数为本版补充的合成数据，与既有WBC/Hb/PLT保持一致。

参考区间为本模拟实验室设定；仅用于该教学病例，非特定品牌试剂说明书。

检验者：模拟检验师A 审核者：模拟检验师B（均为角色标识，未作真实签署）

模拟教学医院

生化检验报告单

姓名：张建国（虚构） 性别：男 年龄：58岁 病案号：SIM-AMI-20260901

科室：心血管内科 / CCU 入院：2026-09-01 09:20 出院：2026-09-07 10:00

报告编号：SIM-BIO-0901 标本：血清 标本状态：合格（模拟）

采样：09-01 09:28 接收：09:32 报告：10:00

检验项目	结果	提示	单位	参考区间
钾 K	3.8		mmol/L	3.5 – 5.3
钠 Na	139		mmol/L	137 – 147
镁 Mg	0.84		mmol/L	0.75 – 1.02
肌酐 Cr	82		μmol/L	57 – 97
估算肾小球滤过率	95		mL/min/1.73m^2	≥90
尿素 Urea	5.6		mmol/L	3.1 – 8.0
丙氨酸氨基转移酶 ALT	28		U/L	9 – 50
天门冬氨酸氨基转移酶 AST	36		U/L	15 – 40
总胆红素 TBil	12.6		μmol/L	5 – 21
白蛋白 ALB	43		g/L	40 – 55

结果提示：↑ 高于参考上限；↓ 低于参考下限；空白表示未超出所列区间。

eGFR采用CKD-EPI估算并四舍五入；单次结果不能用于诊断慢性肾病。9月3日白蛋白未复查。

参考区间为本模拟实验室设定；仅用于该教学病例，非特定品牌试剂说明书。

检验者：模拟检验师A 审核者：模拟检验师B（均为角色标识，未作真实签署）

模拟教学医院

生化检验报告单

姓名：张建国（虚构） 性别：男 年龄：58岁 病案号：SIM-AMI-20260901

科室：心血管内科 / CCU 入院：2026-09-01 09:20 出院：2026-09-07 10:00

报告编号：SIM-BIO-0903 标本：血清 标本状态：合格（模拟）

采样：09-03 06:00 接收：06:12 报告：07:05

检验项目	结果	提示	单位	参考区间
钾 K	4.2		mmol/L	3.5 – 5.3
钠 Na	140		mmol/L	137 – 147
镁 Mg	0.89		mmol/L	0.75 – 1.02
肌酐 Cr	84		μmol/L	57 – 97
估算肾小球滤过率	92		mL/min/1.73m^2	≥90
尿素 Urea	5.4		mmol/L	3.1 – 8.0
丙氨酸氨基转移酶 ALT	31		U/L	9 – 50
天门冬氨酸氨基转移酶 AST	78	↑	U/L	15 – 40
总胆红素 TBil	11.8		μmol/L	5 – 21

结果提示：↑ 高于参考上限；↓ 低于参考下限；空白表示未超出所列区间。

eGFR采用CKD-EPI估算并四舍五入；单次结果不能用于诊断慢性肾病。9月3日白蛋白未复查。

参考区间为本模拟实验室设定；仅用于该教学病例，非特定品牌试剂说明书。

检验者：模拟检验师A 审核者：模拟检验师B（均为角色标识，未作真实签署）

模拟教学医院

生化检验报告单

姓名：张建国（虚构） 性别：男 年龄：58岁 病案号：SIM-AMI-20260901

科室：心血管内科 / CCU 入院：2026-09-01 09:20 出院：2026-09-07 10:00

报告编号：SIM-BIO-0906 标本：血清 标本状态：合格（模拟）

采样：09-06 06:00 接收：06:12 报告：07:05

检验项目	结果	提示	单位	参考区间
钾 K	4.3		mmol/L	3.5 – 5.3
钠 Na	140		mmol/L	137 – 147
镁 Mg	0.9		mmol/L	0.75 – 1.02
肌酐 Cr	80		μmol/L	57 – 97
估算肾小球滤过率	98		mL/min/1.73m^2	≥90
尿素 Urea	5.2		mmol/L	3.1 – 8.0
丙氨酸氨基转移酶 ALT	30		U/L	9 – 50
天门冬氨酸氨基转移酶 AST	29		U/L	15 – 40
总胆红素 TBil	12.1		μmol/L	5 – 21
白蛋白 ALB	41		g/L	40 – 55

结果提示：↑ 高于参考上限；↓ 低于参考下限；空白表示未超出所列区间。

eGFR采用CKD-EPI估算并四舍五入；单次结果不能用于诊断慢性肾病。9月3日白蛋白未复查。

参考区间为本模拟实验室设定；仅用于该教学病例，非特定品牌试剂说明书。

检验者：模拟检验师A 审核者：模拟检验师B（均为角色标识，未作真实签署）

模拟教学医院

血脂检验报告单

姓名：张建国（虚构） 性别：男 年龄：58岁 病案号：SIM-AMI-20260901

科室：心血管内科 / CCU 入院：2026-09-01 09:20 出院：2026-09-07 10:00

报告编号：SIM-LIP-0901 标本：血清（入院、降脂前） 标本状态：合格（模拟）

采样：09-01 09:28 接收：09:32 报告：10:10

检验项目	结果	提示	单位	参考区间
总胆固醇 TC	6.12	↑	mmol/L	<5.2（理想水平）
低密度脂蛋白 LDL-C	4.05	↑	mmol/L	<3.4（一般人群）
高密度脂蛋白 HDL-C	0.98	↓	mmol/L	≥1.0
甘油三酯 TG	1.86	↑	mmol/L	<1.7
非HDL-C	5.14	↑	mmol/L	<4.1（一般人群）

结果提示：↑ 高于参考上限；↓ 低于参考下限；空白表示未超出所列区间。

本例为ACS二级预防：LDL-C治疗目标＜1.4 mmol/L且较基线降低≥50%，严于表内一般人群提示界值。采样非空腹，TG需结合采样状态解读。

参考区间为本模拟实验室设定；仅用于该教学病例，非特定品牌试剂说明书。

检验者：模拟检验师A 审核者：模拟检验师B（均为角色标识，未作真实签署）

模拟教学医院

凝血功能检验报告单

姓名：张建国（虚构） 性别：男 年龄：58岁 病案号：SIM-AMI-20260901

科室：心血管内科 / CCU 入院：2026-09-01 09:20 出院：2026-09-07 10:00

报告编号：SIM-COAG-0901 标本：枸橼酸钠抗凝血浆 标本状态：合格（模拟）

采样：09-01 09:28 接收：09:32 报告：09:55

检验项目	结果	提示	单位	参考区间
凝血酶原时间 PT	11.8		s	10 - 14
国际标准化比值 INR	1.02			0.80 - 1.20
活化部分凝血活酶时间	29		s	25 - 35
纤维蛋白原 FIB	3.4		g/L	2.0 - 4.0

结果提示：↑ 高于参考上限；↓ 低于参考下限；空白表示未超出所列区间。

本标本采集于肝素使用前。术中ACT 286秒见手术记录，不能用未抗凝凝血参考区间解释。

参考区间为本模拟实验室设定；仅用于该教学病例，非特定品牌试剂说明书。

检验者：模拟检验师A 审核者：模拟检验师B（均为角色标识，未作真实签署）

模拟教学医院

心肌损伤标志物报告汇编

姓名：张建国（虚构） 性别：男 年龄：58岁 病案号：SIM-AMI-20260901

科室：心血管内科 / CCU 入院：2026-09-01 09:20 出院：2026-09-07 10:00

检测标本：血清；hs-cTnI方法：高敏免疫测定（模拟）；CK-MB：质量浓度法。

SIM-MARK-01 采样：09-01 09:28 接收：09:32 报告：09:50

项目	结果	提示	参考上限
hs-cTnI	186 ng/L	↑	男性第99百分位：34 ng/L
CK-MB	8.6 ng/mL	↑	5.0 ng/mL

SIM-MARK-02 采样：09-01 15:00 接收：15:10 报告：15:40

项目	结果	提示	参考上限
hs-cTnI	18600 ng/L	↑	男性第99百分位：34 ng/L
CK-MB	126 ng/mL	↑	5.0 ng/mL

SIM-MARK-03 采样：09-02 06:00 接收：06:12 报告：06:45

项目	结果	提示	参考上限
hs-cTnI	32400 ng/L	↑	男性第99百分位：34 ng/L
CK-MB	184 ng/mL	↑	5.0 ng/mL

本页为前三次独立标本报告的汇编。参考上限按本模拟实验室设定。

检验者：模拟检验师A 审核者：模拟检验师B（均为角色标识，未作真实签署）

模拟教学医院

心肌损伤标志物报告汇编（续）

姓名：张建国（虚构） 性别：男 年龄：58岁 病案号：SIM-AMI-20260901

科室：心血管内科 / CCU 入院：2026-09-01 09:20 出院：2026-09-07 10:00

检测标本：血清；以下为住院后期三次独立标本报告。

SIM-MARK-04 采样：09-03 06:00 接收：06:12 报告：06:45

项目	结果	提示	参考上限
hs-cTnI	14800 ng/L	↑	男性第99百分位：34 ng/L
CK-MB	48 ng/mL	↑	5.0 ng/mL

SIM-MARK-05 采样：09-04 06:00 接收：06:12 报告：06:45

项目	结果	提示	参考上限
hs-cTnI	5260 ng/L	↑	男性第99百分位：34 ng/L
CK-MB	4.6 ng/mL		5.0 ng/mL

SIM-MARK-06 采样：09-06 06:00 接收：06:12 报告：06:45

项目	结果	提示	参考上限
hs-cTnI	780 ng/L	↑	男性第99百分位：34 ng/L
CK-MB	未复查		5.0 ng/mL

以上为6次独立标本的汇编，非同一次检测；肌钙蛋白并非出院必须正常。标本时间均为2026年。

检验者：模拟检验师A 审核者：模拟检验师B（均为角色标识，未作真实签署）

模拟教学医院

糖代谢、心衰标志物及尿液报告汇编

姓名：张建国（虚构） 性别：男 年龄：58岁 病案号：SIM-AMI-20260901

科室：心血管内科 / CCU 入院：2026-09-01 09:20 出院：2026-09-07 10:00

报告编号：SIM-OTHER 标本：见项目说明 标本状态：合格（模拟）

采样：见下表 接收：采样后约10分钟 报告：见备注

检验项目	结果	提示	单位	参考区间
随机血糖（09-01 09:28）	8.2	↑	mmol/L	3.9 – 7.8*
空腹血糖（09-02 06:00）	5.7		mmol/L	3.9 – 6.1
空腹血糖（09-06 06:00）	5.5		mmol/L	3.9 – 6.1
HbA1c（09-02 06:00）	5.6		%	4.0 – 6.0
NT-proBNP（09-01 09:28）	210	↑	pg/mL	<125*
NT-proBNP（09-02 06:00）	680	↑	pg/mL	<125*
NT-proBNP（09-06 06:00）	260	↑	pg/mL	<125*
尿蛋白（09-02 06:20）	阴性			阴性
尿潜血（同上）	阴性			阴性
尿糖（同上）	阴性			阴性

结果提示：↑ 高于参考上限；↓ 低于参考下限；空白表示未超出所列区间。

*随机血糖箭头仅按本模拟实验室提示界值，不能据此诊断糖尿病。NT-proBNP采用非急性参考界值，非急性心衰确诊阈值；本例无临床心衰。血糖及NT-proBNP用血清，HbA1c用EDTA全血，尿常规为晨尿。各项目报告为采样后约60分钟；此页是汇编，非单一标本原单。

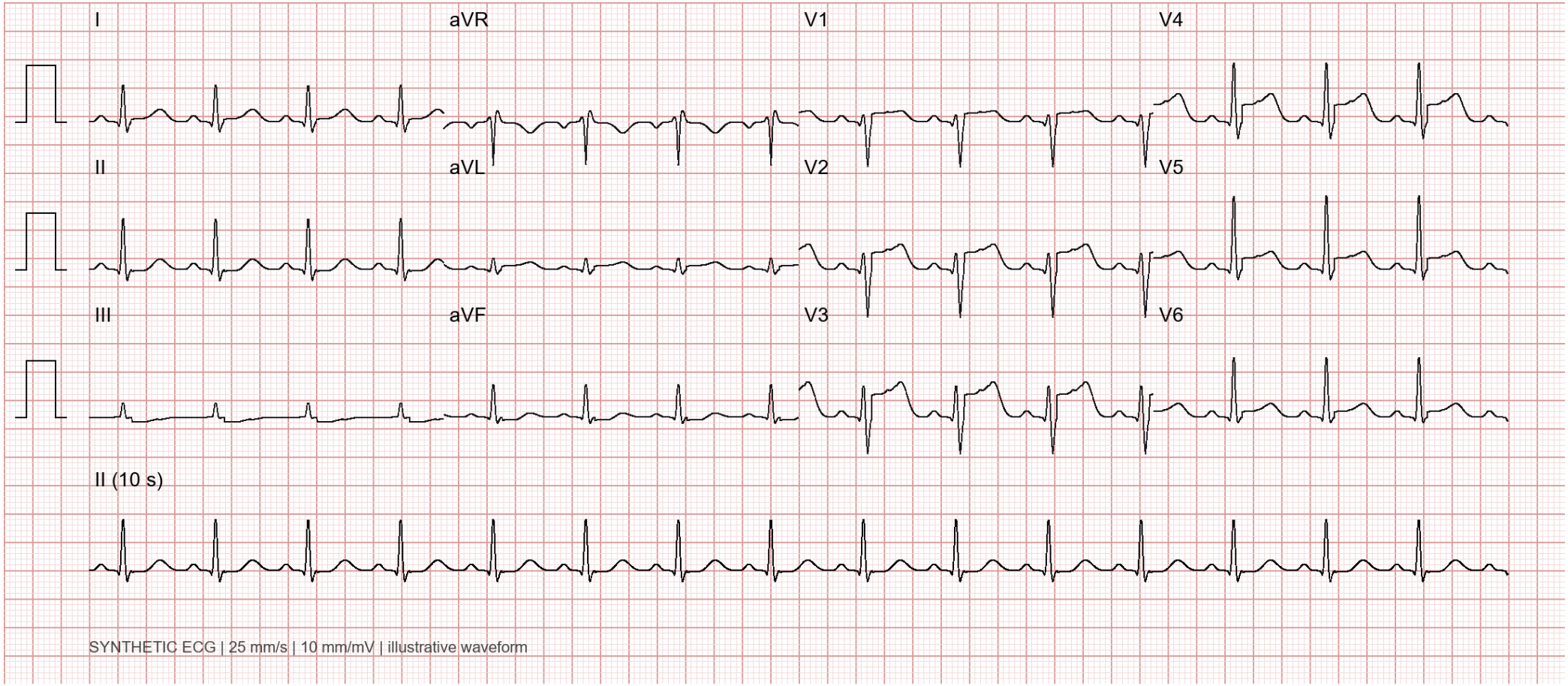
参考区间为本模拟实验室设定；仅用于该教学病例，非特定品牌试剂说明书。

检验者：模拟检验师A 审核者：模拟检验师B（均为角色标识，未作真实签署）

模拟教学医院

十二导联心电图报告单

张建国（虚构） 男 / 58岁 SIM-AMI-20260901 检查：2026-09-01 09:25 心率：92次/分 急性期



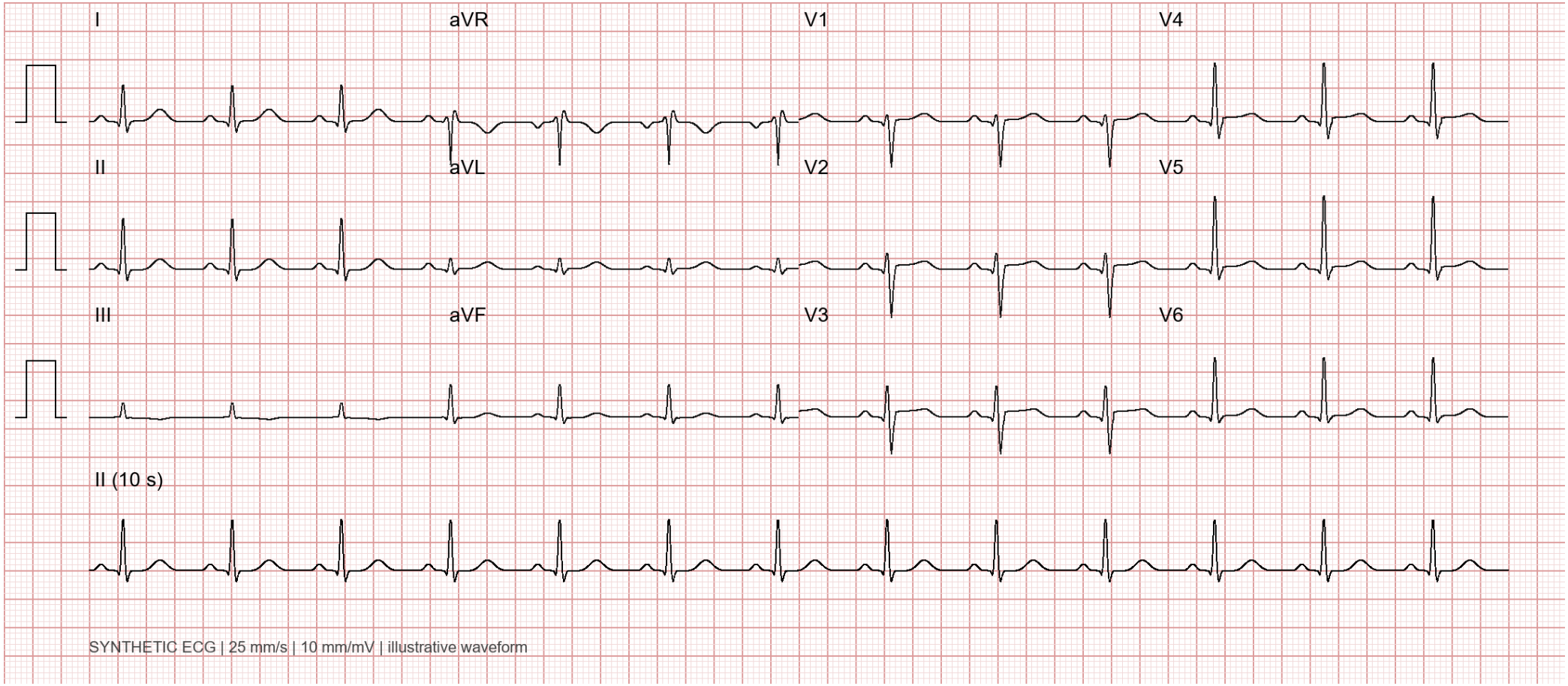
窦性心律；PR 160 ms，QRS 90 ms（病例设定值）。V_1～V_6 ST抬高依次约1.5、3、4、3、2、1 mm；Ⅰ、aVL轻度抬高，Ⅲ、aVF压低约0.5～1 mm；V_2～V_4 T波高耸。提示：急性广泛前壁STEMI。

合成示意波形，非设备采集；报告定量值为病例设定，不应用图像自动测量替代。原尺寸打印：25 mm/s、10 mm/mV；缩放打印将改变纸面定标。

模拟教学医院

十二导联心电图报告单

张建国（虚构） 男 / 58岁 SIM-AMI-20260901 检查：2026-09-01 11:20 心率：78次/分 再灌注后



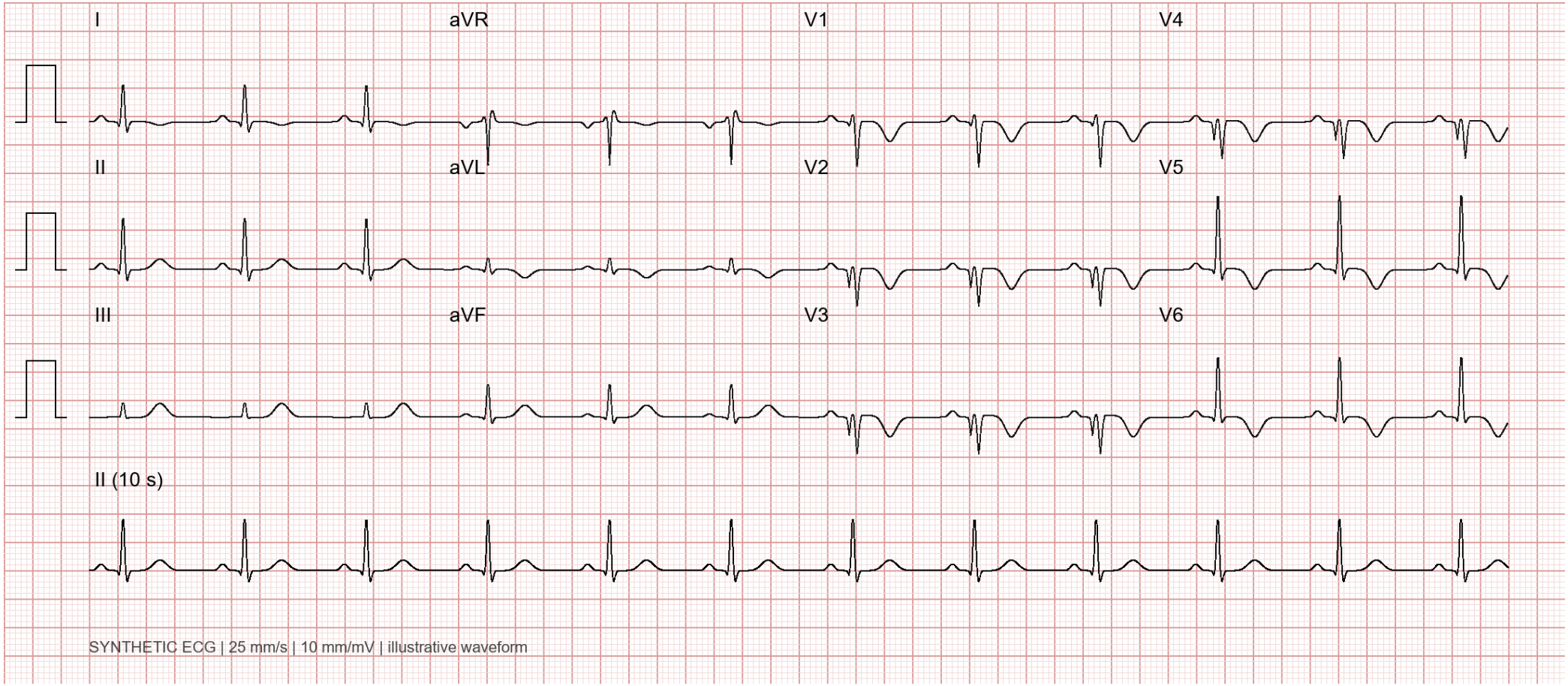
窦性心律。V_3 ST抬高由4 mm降至约1 mm，其他抬高导联明显回落，胸前导联ST抬高总幅度下降＞70%。结合胸痛消失及TIMI 3级血流，支持再灌注有效。

合成示意波形，非设备采集；报告定量值为病例设定，不应用图像自动测量替代。原尺寸打印：25 mm/s、10 mm/mV；缩放打印将改变纸面定标。

模拟教学医院

十二导联心电图报告单

张建国（虚构） 男 / 58岁 SIM-AMI-20260901 检查：2026-09-02 07:00 心率：70次/分 梗死演变期



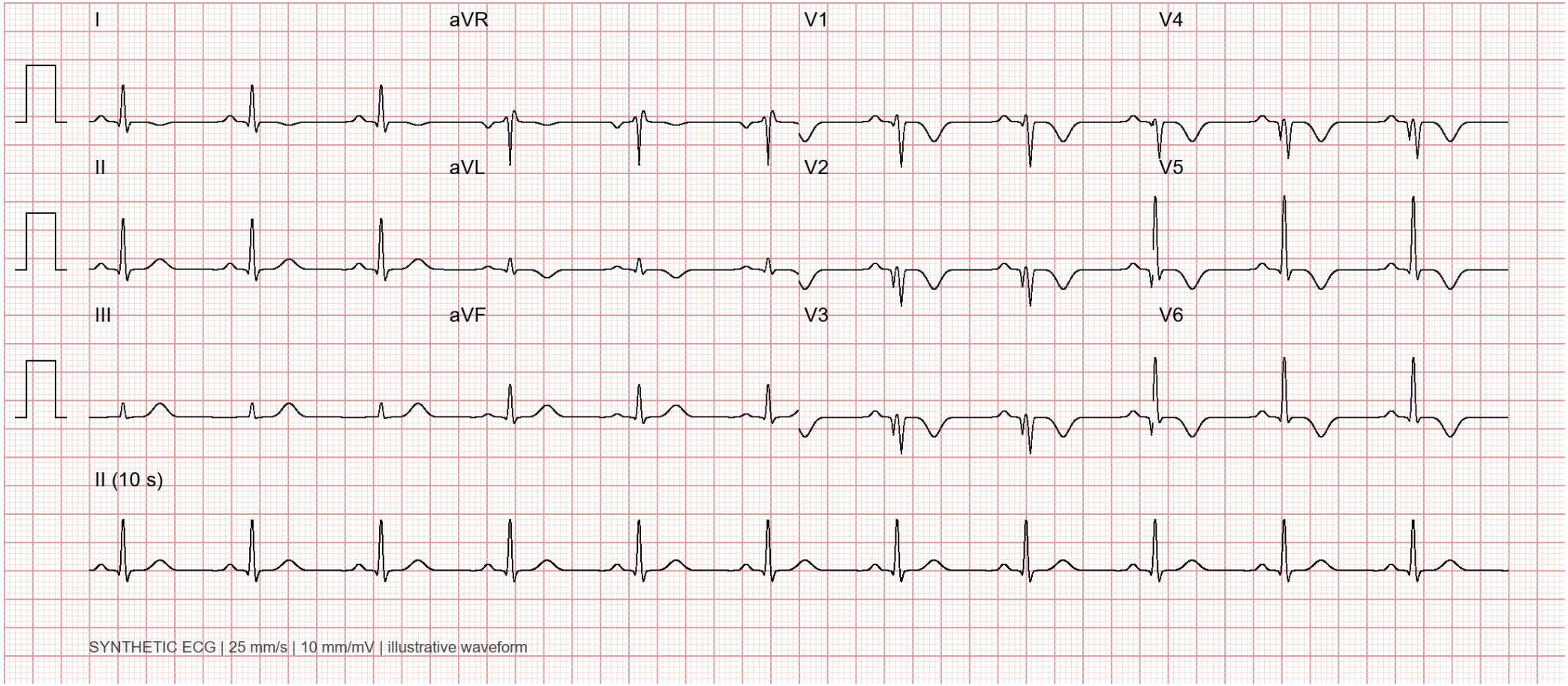
窦性心律；V_2～V_4病理性Q波或QS波，V_2～V_6 T波倒置，残余ST抬高≤0.5 mm。提示前壁心梗演变，无新发急性缺血表现。

合成示意波形，非设备采集；报告定量值为病例设定，不应用图像自动测量替代。原尺寸打印：25 mm/s、10 mm/mV；缩放打印将改变纸面定标。

模拟教学医院

十二导联心电图报告单

张建国（虚构） 男 / 58岁 SIM-AMI-20260901 检查：2026-09-06 08:00 心率：66次/分 出院前



窦性心律；V_2～V_4 Q波持续，V_2～V_6 T波倒置，无新发ST抬高或压低。提示梗死后演变。

合成示意波形，非设备采集；报告定量值为病例设定，不应用图像自动测量替代。原尺寸打印：25 mm/s、10 mm/mV；缩放打印将改变纸面定标。

模拟教学医院

超声心动图检查报告单

姓名：张建国（虚构） 性别：男 年龄：58岁 病案号：SIM-AMI-20260901

科室：心血管内科 / CCU 入院：2026-09-01 09:20 出院：2026-09-07 10:00

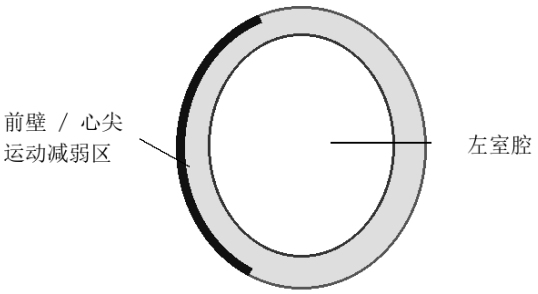
检查时间：2026-09-01 12:10 检查方式：经胸超声心动图 报告编号：SIM-ECHO-01

项目	结果	提示/解释
左室舒张末内径	51 mm	初次测量；复查不虚构新值
LVEF（双平面Simpson）	45%	↓ 低于本报告男性参考下限52%
节段性室壁运动	前壁、前间隔中远段及心尖运动减弱	异常，与前降支供血区相符
右室	初次大小及收缩功能正常	复查未提示新异常
瓣膜	轻度二尖瓣反流	初次所见，结合临床随访
左室血栓	未见明确附壁血栓	常规经胸超声有检出局限
其他	未见室间隔穿孔、明显乳头肌断裂或心包积液	无明确机械并发症

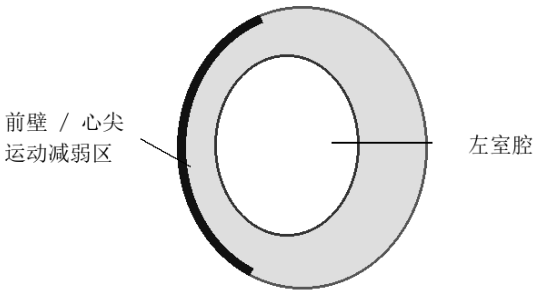
超声提示

左室前降支供血区节段性运动异常，左室整体收缩功能轻度减低。结合急性前壁心肌梗死病史。

舒张末期（结构示意）



收缩末期（运动示意）



LVEF病例设定：45% ｜ 示意轮廓不用于计算容积或射血分数

非超声采集图；无设备、探头或DICOM数据。用于解释节段性运动异常。

检查医师：模拟超声医师A 审核医师：模拟超声医师B（均为角色标识，未作真实签署）

模拟教学医院

超声心动图检查报告单

姓名：张建国（虚构） 性别：男 年龄：58岁 病案号：SIM-AMI-20260901

科室：心血管内科 / CCU 入院：2026-09-01 09:20 出院：2026-09-07 10:00

检查时间：2026-09-06 08:30 检查方式：经胸超声心动图 报告编号：SIM-ECHO-02

项目	结果	提示/解释
左室舒张末内径	未新增设定	初次测量；复查不虚构新值
LVEF（双平面Simpson）	50%	↓ 低于本报告男性参考下限52%
节段性室壁运动	前壁、前间隔中远段及心尖运动减弱	异常；复查较前改善
右室	初次大小及收缩功能正常	复查未提示新异常
瓣膜	轻度二尖瓣反流	初次所见，结合临床随访
左室血栓	未见明确附壁血栓	常规经胸超声有检出局限
其他	未见室间隔穿孔、明显乳头肌断裂或心包积液	无明确机械并发症

超声提示

左室前降支供血区节段性运动异常，左室整体收缩功能轻度减低。较9月1日改善，但LVEF 50%仍低于本报告男性参考下限；不能描述为完全正常。



LVEF病例设定：50% | 示意轮廓不用于计算容积或射血分数

非超声采集图；无设备、探头或DICOM数据。用于解释节段性运动异常。

检查医师：模拟超声医师A 审核医师：模拟超声医师B（均为角色标识，未作真实签署）

模拟教学医院

胸部X线检查报告单

姓名：张建国（虚构） 性别：男 年龄：58岁 病案号：SIM-AMI-20260901

科室：心血管内科 / CCU 入院：2026-09-01 09:20 出院：2026-09-07 10:00

检查时间：2026-09-01 13:00 报告时间：13:30 编号：SIM-CXR-0901

检查方式

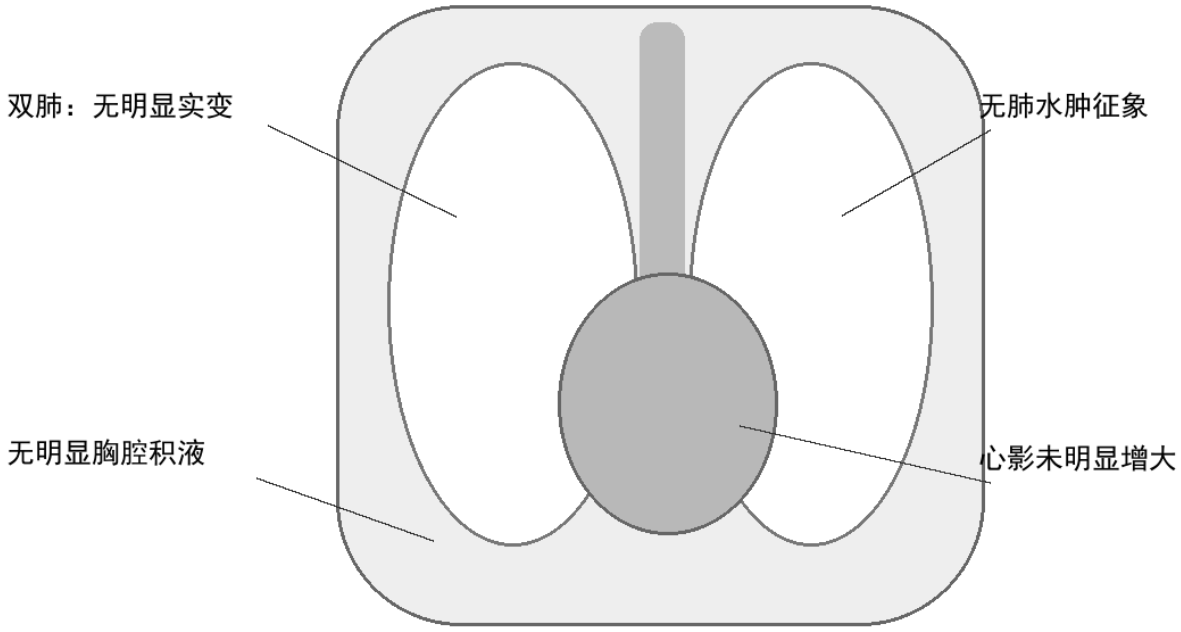
床旁胸部正位摄影。PCI后检查，未延误冠脉再灌注。

影像所见

双肺未见明显实变影或肺水肿征象，肋膈角未见明显变钝，未见明显胸腔积液。心影无明显增大。

影像印象

未见明确急性肺部实变、肺水肿及胸腔积液。床旁正位片对心脏大小及部分病变评估有限，应结合临床。



胸片文字所见的结构示意，非X线影像；不用于影像判读。

图为上述文字所见的教学示意。正常胸片不能用于排除急性冠脉综合征、肺栓塞或主动脉夹层。

报告医师：模拟放射医师A 审核医师：模拟放射医师B（均为角色标识，未作真实签署）

模拟教学医院

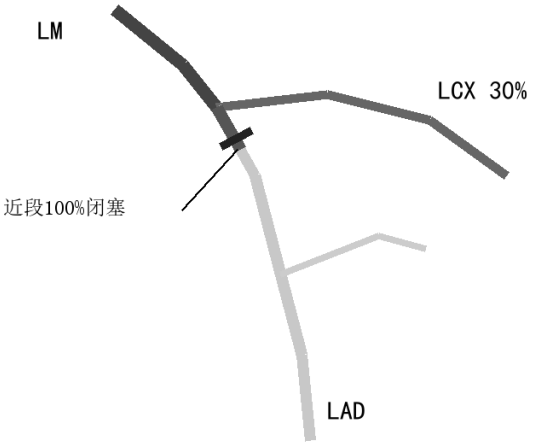
冠状动脉介入前后示意

姓名：张建国（虚构） 性别：男 年龄：58岁 病案号：SIM-AMI-20260901

科室：心血管内科 / CCU 入院：2026-09-01 09:20 出院：2026-09-07 10:00

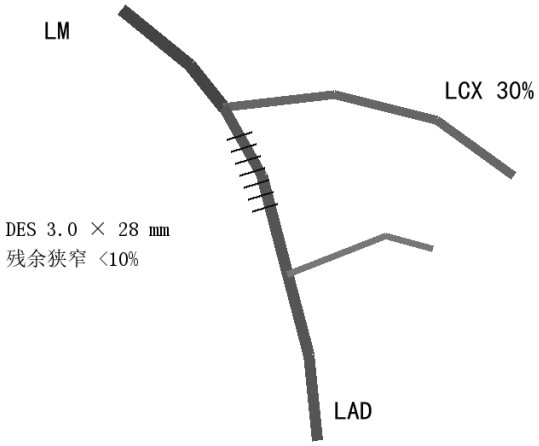
与手术记录对应的解剖示意图；不是冠脉造影帧，也不具备影像诊断效力。

术前：近段闭塞 / TIMI 0级



冠脉结构示意，非造影影像；RCA中段40%（未绘）

术后：TIMI 3级



冠脉结构示意，非造影影像；RCA中段40%（未绘）

审核点	病例设定
罪犯血管	LAD近段，第一对角支开口前
血流变化	TIMI 0 → 2（预扩张后）→ 3（支架及优化后）
支架	3.0×28 mm药物洗脱支架；近中段3.5 mm非顺应性球囊后扩张
影像优化	IVUS最小支架面积约7.1 mm^2，贴壁满意，无边缘夹层
非罪犯血管	LCX中段30%，RCA中段40%；本次无需介入

如需开展正式影像判读能力评估，应补充经授权、脱敏的真实心电图/超声/冠脉造影数据；本件的合成图片适合病例逻辑审核。

模拟教学医院
编制依据与数据说明

知识依据与指南范围

依据《内科学》急性心肌梗死的症状、心电图演变、心肌标志物及并发症框架编写；未指定教材版本，未虚构页码或原文引述。病例数值均为人工设定，不取自真实患者。

1. 2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI急性冠脉综合征指南
用于急诊再灌注、介入及抗栓策略。

2. AHA：2025 ACS指南核心要点
无高出血风险ACS默认双联抗血小板至少12个月，随风险调整。

3. 2023 ESC急性冠脉综合征指南
用于STEMI紧急再灌注与住院、长期管理框架。

4. ESC：ACS后的长期临床管理
LDL-C＜1.4 mmol/L且下降≥50%；4～6周复查血脂。

5. JACC：2026血脂管理指南入口
纳入2026血脂管理更新的二级预防框架。

本版规范化处理

明确首剂他汀当日不重复；双联抗血小板维持时间单列。补齐检验标本及报告时间等合成元数据。出院LVEF 50%仍标↓。随机血糖及NT-proBNP的提示界值与诊断阈值分开。所有新增时间仅用于模拟排版，不声称来自设备或医院信息系统。

图片与参考区间的限制

四张十二导联心电图为程序生成的示意信号，满足纸面速度与幅度定标、体现ST/T/Q演变，但不等同完整生理电信号。超声、胸片、冠脉采用明确标注的结构/运动示意，非原始医学影像；不适合考核真实影像判读能力。检验参考区间和性别阈值采用本模拟实验室设定，真实使用须以实际设备、试剂和机构为准。

检索/编制日期：2026-09-10。引用链接可点击；指南用于解释编制原则，不能把合成患者数值当作指南实证数据。

模拟教学医院

临床专家审核意见表

病例编号：SIM-AMI-20260901 版本：v1.0 审核专家：_____ 日期：_____

审核维度	建议重点	意见
病史与诊断	胸痛特征、鉴别诊断、定位、1型心梗依据	
时间轴	心电图、给药、导丝、球囊、支架、术后报告	
检验一致性	参考区间、↑↓、单位、动态趋势及采样状态	
心电图	ST/T/Q演变是否与LAD闭塞及再灌注相符	
介入治疗	罪犯血管、支架尺寸、IVUS、抗凝及操作逻辑	
住院管理	心功能评估、并发症排查、药物选择及剂量	
出院方案	DAPT、降脂、康复、复查及急救教育	
教学适用性	合成图局限、病例难度及可训练决策点	

总体意见：☐ 可用于教学 ☐ 修改后使用 ☐ 需重构病例（请手工勾选）

需修改的页码、问题及建议